- Aníma — Documentación Clínica y de Diseño
  - 1. Filosofía General de la Aplicación
    - 1.1 ¿Qué es Aníma?
    - 1.2 Bases Teóricas Generales
    - 1.3 Principio de Personalización Clínica
  - 2. Sistema de Rutas Emocionales
    - 2.1 Concepto
    - 2.2 Ruta del Renacer 🌅
    - 2.3 Ruta de Autocompasión 💗
    - 2.4 Ruta de Balance ⚖️
    - 2.5 Ruta del Descubrimiento 🧭
    - 2.6 Ruta de la Soledad 🌌
  - 3. Actividades Terapéuticas
    - 3.1 Respiración Guiada 🍃
    - 3.2 Diario Estelar ⭐
    - 3.3 Relajación Muscular Progresiva 🧘
    - 3.4 Conexión 5 Sentidos (Grounding) 🌍
    - 3.5 Cápsula de Papel 🔥
    - 3.6 Pomodoro de Paz 🍅
    - 3.7 Diario Ciego 👁️
    - 3.8 El Semáforo de Energía 🚦
    - 3.9 El Astillero de Victorias 🚢
    - 3.10 Abrazo de Mariposa Háptico 🦋
    - 3.11 Mensaje en una Botella 🌊
  - 4. Funcionalidades de Soporte
    - 4.1 Micro-Retos Aleatorios 🎲
    - 4.2 Radar de Conexión (Citas Contigo Mismo) 📡
    - 4.3 SOS Adaptativo 🆘
    - 4.4 Chat con Lumi 💬
    - 4.5 Registro de Estado de Ánimo 📊
  - 5. Decisiones de Diseño UX/UI
    - 5.1 Paleta de Colores
    - 5.2 Mascota (Lumi) 🧸
    - 5.3 Animaciones y Micro-interacciones
    - 5.4 Avatares de Perfil 🎨
    - 5.5 Exclusividad de Herramientas por Ruta 🔒
    - 5.6 Sonidos Ambientales 🔊

- 5.7 Afirmaciones Diarias ✨
- 6. Seguridad y Ética
  - 6.1 Disclaimer Médico
  - 6.2 Privacidad
  - 6.3 Líneas Rojas de Diseño
- 7. Referencias Bibliográficas

Aníma — Documentación Clínica y de Diseño

> **Versión:** 1.0 — Febrero 2026
> **Propósito:** Justificación clínica, psicológica y de diseño de cada funcionalidad de la aplicación Aníma.
> **Audiencia:** Evaluadores académicos, psicólogos revisores, equipo de desarrollo.

---

1. Filosofía General de la Aplicación

1.1 ¿Qué es Aníma?

Aníma es una aplicación móvil de acompañamiento emocional diseñada para jóvenes universitarios (18–30 años). **No es una herramienta de diagnóstico ni un sustituto de terapia profesional.** Es un espacio seguro digital que ofrece herramientas de psicoeducación, autorregulación y activación conductual basadas en evidencia.

1.2 Bases Teóricas Generales

Marco Teórico	Aplicación en Aníma
Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)	Reestructuración cognitiva, diarios de pensamiento, activación conductual
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)	Aceptación emocional sin juicio, valores como motor de acción

Marco Teórico	Aplicación en Aníma
Mindfulness y Atención Plena	Respiración guiada, grounding sensorial 5-4-3-2-1
Psicología Positiva (Seligman)	Diario de gratitud, afirmaciones diarias, celebración de micro-logros
Terapia EMDR (Shapiro)	Estimulación bilateral en "Abrazo de Mariposa Háptico"
Activación Conductual (Martell et al.)	Micro-retos, Astillero de Victorias, romper ciclos de inactividad
Higiene del Sueño Digital	Semáforo de Energía (bloqueo nocturno)
Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan)	Autonomía en selección de rutas, competencia vía gamificación, conexión vía comunidad

1.3 Principio de Personalización Clínica

En lugar de ofrecer un set genérico de herramientas, Aníma dirige al usuario a una **ruta emocional personalizada** basada en un triage inicial. Esto se basa en el principio clínico de que las intervenciones son más eficaces cuando están adaptadas al perfil del paciente (Norcross & Wampold, 2011).

---

2. Sistema de Rutas Emocionales

2.1 Concepto

Las 5 rutas son perfiles emocionales, no diagnósticos. Cada una agrupa estrategias clínicas validadas para un perfil de malestar específico.

2.2 Ruta del Renacer 🌅

Aspecto	Detalle
Perfil de usuario	Ánimo bajo, desmotivación, apatía, síntomas depresivos leves
Enfoque clínico	Activación Conductual (Martell, Addis & Jacobson, 2001)
Principio clave	*"Actuar primero, la motivación llegará después"* — romper el ciclo depresivo de inactividad → culpa → más inactividad
Estrategias implementadas	Mantener rutina mínima, aceptar la emoción sin juzgarla, reescribir narrativas
Color: Amarillo/ Ámbar	Psicología del color: el amarillo evoca energía, optimismo y calidez sin ser agresivo (Elliot & Maier, 2014)

2.3 Ruta de Autocompasión 💗

Aspecto	Detalle
Perfil de usuario	Sentimiento de rechazo, vergüenza, autocrítica destructiva
Enfoque clínico	Autocompasión (Kristin Neff, 2003) + Exposición gradual
Principio clave	Tratarse a uno mismo como trataríamos a un amigo querido
Estrategias	Normalizar el rechazo como experiencia universal, diálogo interno amable, contacto social gradual
Color: Rosa	Simboliza ternura, cuidado y amor propio. Contrarresta la dureza de la autocrítica

2.4 Ruta de Balance ⚖️

Aspecto	Detalle
Perfil de usuario	Burnout académico/laboral, estrés crónico, incapacidad de desconectar

Aspecto	Detalle
Enfoque clínico	Prevención de burnout (Maslach & Leiter, 2016) + Higiene digital
Principio clave	El descanso es productividad a largo plazo; los límites protegen la salud mental
Estrategias	Pausas activas cada 90 min, establecer límites, reducir redes sociales
Color: Verde esmeralda	Asociado con equilibrio, naturaleza y calma fisiológica (Jalil et al., 2012)

2.5 Ruta del Descubrimiento 🧭

Aspecto	Detalle
Perfil de usuario	Incertidumbre sobre el futuro, parálisis por análisis, ataques de pánico anticipatorios
Enfoque clínico	Tolerancia a la incertidumbre (Dugas & Robichaud, 2007)
Principio clave	Explorar en vez de decidir de inmediato; no necesitas el mapa completo
Estrategias	Diario de intereses/curiosidades, diferenciar culpa útil de paralizante
Color: Azul	Transmite profundidad, exploración y confianza (Labrecque & Milne, 2012)

2.6 Ruta de la Soledad 🌌

Aspecto	Detalle
Perfil de usuario	Aislamiento social, sensación de desconexión, dificultad para pedir ayuda
Enfoque clínico	Reestructuración de valores sociales + Reconexión gradual (Cacioppo & Patrick, 2008)

Aspecto	Detalle
Principio clave	Diferenciar "estar solo" de "sentirse solo"; empezar la reconexión por uno mismo
Estrategias	Autocuidado activo a solas, contacto ligero sin presión, espacios comunitarios
Color: Índigo/Púrpura	Evoca profundidad cósmica y pertenencia universal — "no estás solo en el universo"

---

3. Actividades Terapéuticas

3.1 Respiración Guiada 🌿

Aspecto	Detalle
Base clínica	Respiración diafragmática y técnica 4-7-8 (Dr. Andrew Weil)
Mecanismo	Activa el sistema nervioso parasimpático (respuesta de relajación), reduce cortisol y frecuencia cardíaca
Evidencia	Ma et al. (2017): La respiración lenta mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca y reduce la ansiedad estado
Implementación	Animación circular guiada con retroalimentación visual + sonidos ambientales opcionales
Prioridad de ruta	Universal, pero priorizada en Ruta Balance (burnout)

3.2 Diario Estelar ⭐

Aspecto	Detalle
Base clínica	Diario de gratitud (Emmons & McCullough, 2003)
Mecanismo	Reorienta la atención del sesgo de negatividad hacia experiencias positivas, fortaleciendo circuitos neuronales asociados al bienestar

Aspecto	Detalle
Evidencia	Usuarios que escriben 3 cosas positivas diarias por 2 semanas reportan mayor satisfacción vital (Seligman et al., 2005)
Implementación	Cada entrada se convierte en una "estrella" visual en un cielo personal, gamificando la práctica
Diseño	Interfaz de cielo nocturno con estrellas flotantes — metáfora visual de que incluso en la oscuridad hay puntos de luz

3.3 Relajación Muscular Progresiva 🧘

Aspecto	Detalle
Base clínica	Relajación Muscular Progresiva de Jacobson (1938)
Mecanismo	Tensar y soltar grupos musculares sistemáticamente reduce la tensión somática acumulada
Evidencia	Técnica validada por la APA como intervención eficaz para ansiedad y trastornos del sueño
Implementación	Guía paso a paso con animaciones corporales y temporizadores de tensión/relajación

3.4 Conexión 5 Sentidos (Grounding) 🌍

Aspecto	Detalle
Base clínica	Técnica de anclaje sensorial 5-4-3-2-1 (van der Kolk, 2014)
Mecanismo	Redirige la atención desde la rumiación/disociación hacia el presente físico estimulando los 5 sentidos secuencialmente
Evidencia	Utilizada en tratamiento de TEPT y ataques de pánico para interrumpir la respuesta de lucha-huida
Implementación	4 fases multisensoriales interactivas: Visual (identificar colores), Auditivo (reconocer sonidos), Táctil (feedback háptico), Cognitivo (categorización)

Aspecto	Detalle
Prioridad de ruta	Priorizada en Ruta Ansiedad

3.5 Cápsula de Papel 🔥

Aspecto	Detalle
Base clínica	Escritura expresiva (Pennebaker, 1997) + Ritual de externalización
Mecanismo	Externalizar pensamientos negativos en un objeto (papel) y destruirlo simbólicamente reduce la carga emocional asociada. El acto de "quemar" funciona como cierre cognitivo
Evidencia	Briñol et al. (2012): Participantes que escribieron pensamientos negativos y los tiraron a la basura reportaron menor influencia de esos pensamientos sobre sus decisiones
Implementación	Interfaz de "papel virtual" donde el usuario escribe → animación de arrugado/quemado con sonidos inmersivos → los pensamientos se destruyen irrecuperablemente
Diseño deliberado	No hay opción de guardar o revisar lo escrito — esto refuerza el concepto de "soltar" sin rumiar

3.6 Pomodoro de Paz 🍅

Aspecto	Detalle
Base clínica	Técnica Pomodoro (Cirillo, 2006) adaptada con componente de higiene digital
Mecanismo	Períodos de enfoque + descansos obligatorios previenen la fatiga cognitiva y el burnout. Los descansos activos (respiración, estiramiento) son más restauradores que el scroll pasivo
Evidencia	DeskTime (2014): Los empleados más productivos trabajan 52 min y descansan 17. El ciclo 25/5 es accesible para jóvenes

Aspecto	Detalle
Implementación	Temporizador circular con mascota que "estudia contigo" → en descanso, suena lluvia y la mascota te guía en micro-ejercicios
Prioridad de ruta	Exclusiva Ruta Balance (Burnout)

3.7 Diario Ciego 👁‍🗨

Aspecto	Detalle
Base clínica	Brain Dump / Escritura de flujo de conciencia (Cameron, "The Artist's Way", 1992)
Mecanismo	El texto desaparece mientras se escribe → elimina la auto-edición, el perfeccionismo y la autocensura. Obliga al cerebro a *soltar* ideas sin juzgarlas
Evidencia	La escritura libre sin revisión reduce la rumiación obsesiva en personas con tendencia a sobre-analizar (Nolen-Hoeksema, 2000)
Implementación	Texto con opacidad decreciente; las palabras se desvanecen progresivamente. No hay botón de guardar ni de retroceder
Exclusividad	Ruta Descubrimiento — diseñada para personas con parálisis por análisis

3.8 El Semáforo de Energía 🚦

Aspecto	Detalle
Base clínica	Higiene del sueño digital (Walker, "Why We Sleep", 2017)
Mecanismo	Después de las 10 PM, bloquear actividades estimulantes y fomentar solo herramientas calmantes (respiración, sonidos) reduce la activación cognitiva antes de dormir
Evidencia	La exposición a contenido estimulante y decisiones activas después de las 10 PM retrasa el inicio del sueño en promedio 45 minutos (Chang et al., 2015)

Aspecto	Detalle
Implementación	Banner visual + mascota envuelta en cobija. Solo Respiración y Sonidos Ambientales quedan accesibles
Exclusividad	Ruta Balance — usuarios con burnout tienden a abusar de la productividad nocturna

3.9 El Astillero de Victorias 🚢

Aspecto	Detalle
Base clínica	Validación basal y micro-logros (Linehan, DBT Skills Training, 1993)
Mecanismo	Literaliza "pasos de bebé" — un barco que avanza 1 pixel por cada micro-victoria. Contrarresta el sesgo de negatividad depresivo que invalida los logros
Evidencia	Amabile & Kramer (2011, "The Progress Principle"): Percibir progreso, aunque sea mínimo, es el mayor motivador intrínseco
Implementación	Input de logro mínimo (ej. "Me lavé la cara") → barco con animación de avance + feedback háptico + celebración
Exclusividad	Ruta Renacer — usuarios con depresión leve necesitan evidencia tangible de que "están avanzando"

3.10 Abrazo de Mariposa Háptico 🦋

Aspecto	Detalle
Base clínica	Estimulación Bilateral derivada de EMDR (Shapiro, 1989) + Técnica de Abrazo de Mariposa (Artigas et al., 2000)
Mecanismo	La estimulación bilateral alternada (izquierda-derecha) activa ambos hemisferios cerebrales secuencialmente, facilitando el procesamiento emocional y reduciendo la activación del sistema de alarma (amígdala)
Evidencia	Artigas et al. (2000) desarrollaron esta técnica para víctimas de desastres naturales. Grand (2013) confirma que la estimulación

Aspecto	Detalle
	bilateral reduce el SUDS (nivel subjetivo de malestar)
Implementación	Motor háptico alternando vibraciones izquierda-derecha a ritmo cardíaco. Animación de alas de mariposa sincronizadas. Temporizador de sesión con protección contra memory leaks
Exclusividad	Ruta Autocompasión — usuarios con somatización de culpa/vergüenza necesitan regulación corporal, no solo cognitiva

3.11 Mensaje en una Botella 🌊

Aspecto	Detalle
Base clínica	Altruismo recíproco (Trivers, 1971) + Sentido de pertenencia (Baumeister & Leary, 1995)
Mecanismo	Escribir un mensaje de aliento para un desconocido activa los circuitos de empatía y propósito. Recibir uno de vuelta valida que "no eres el único" — rompe la ilusión de aislamiento total
Evidencia	Aknin et al. (2013): Actos prosociales (incluso mínimos) aumentan el bienestar subjetivo del emisor. Post & Neimark (2007): Ayudar a otros reduce la percepción de soledad
Implementación	Interfaz marítima animada. El usuario escribe → lanza al mar → espera (pausa activa) → recibe un mensaje anónimo
Exclusividad	Ruta Soledad — diseñada para dar sensación de comunidad sin la presión de mantener una conversación

---

4. Funcionalidades de Soporte

4.1 Micro-Retos Aleatorios 🎲

Aspecto	Detalle
Base clínica	Activación conductual + Gamificación terapéutica

Aspecto	Detalle
Mecanismo	Retos de < 5 min adaptados a la ruta del usuario. La aleatoriedad añade novedad (activa dopamina) y la brevedad elimina la barrera de entrada
Diseño	Tarjeta tipo "rasca y gana" en el Home — la interacción lúdica reduce la resistencia a actuar

4.2 Radar de Conexión (Citas Contigo Mismo) 📡

Aspecto	Detalle
Base clínica	Autocuidado activo (programar actividades agradables como intervención anti-depresiva)
Mecanismo	Un checklist de actividades de autocuidado contextualizado a la ruta. Al completarlos, se llena un "medidor de energía propia"
Diseño	No es un to-do de productividad, sino de "romanticízate" — esto es intencional para reencuadrar la productividad como cuidado personal

4.3 SOS Adaptativo 🆘

Aspecto	Detalle
Base clínica	Intervención en crisis personalizada — el mismo botón cambia radicalmente según la ruta
Justificación	Un botón genérico de "calma" ignora que una persona con burnout necesita algo diferente a una con aislamiento. La personalización aumenta la eficacia percibida

Variantes por ruta:

Ruta	Intervención SOS	Base Clínica
Balance	Respiración 4-7-8 inmersiva	Regulación vagal (Porges, 2011)

Ruta	Intervención SOS	Base Clínica
Autocompasión	"Línea de Vida" — Lumi lee tus logros pasados	Contraataque a la voz crítica interna (Gilbert, 2009)
Soledad	"Rompehielos Seguro" — textos pre-escritos listos para enviar	Reducción de barrera social (Leary, 2015)
Renacer	"Victoria Microscópica" — hacer 1 cosa absurdamente fácil	Hackeo del sistema de dopamina estancado (Huberman, 2021)
Descubrimiento	"Ancla Visual 5-4-3-2-1" sensorial	Grounding para ataques de pánico anticipatorios (van der Kolk, 2014)

4.4 Chat con Lumi 💬

Aspecto	Detalle
Base clínica	Escucha activa simulada + Psicoeducación
Mecanismo	Lumi no diagnostica ni aconseja profundamente. Valida, normaliza y redirige a las herramientas de la app. Este enfoque evoca la terapia rogeriana (Carl Rogers, 1951): aceptación incondicional positiva
Diseño	Respuestas adaptadas a la ruta emocional del usuario para mantener coherencia clínica
Limitación declarada	El disclaimer clínico es visible y accesible — la app explica que NO reemplaza a un profesional

4.5 Registro de Estado de Ánimo 📊

Aspecto	Detalle
Base clínica	Auto-monitoreo emocional (Beck, 1979 — Terapia Cognitiva)
Mecanismo	Registrar el mood diariamente aumenta la consciencia emocional (alexitimia reducida) y permite detectar patrones

Aspecto	Detalle
Implementación	5 niveles de estado de ánimo con gráfica semanal para visualizar tendencias

5. Decisiones de Diseño UX/UI

5.1 Paleta de Colores

Decisión	Justificación
Modo oscuro tipo "Aurora Boreal"	Los tonos oscuros profundos (índigo, púrpura) reducen la estimulación visual y evocan un espacio seguro nocturno. Las auroras añaden calidez sin ser agresivas
Gradientes suaves	Evitan la dureza visual de colores sólidos, transmitiendo fluidez emocional
Color por ruta	Cada ruta tiene un color diferenciado basado en psicología del color — refuerza la identidad del usuario con su proceso

5.2 Mascota (Lumi) 🧸

Decisión	Justificación
Presencia constante	Lumi aparece en Home, Chat, Actividades y Perfil. Crea un "objeto transicional" digital (Winnicott, 1953) que ofrece sensación de compañía constante
Variantes emocionales	Lumi cambia su expresión según el contexto: empática, meditando, saludando, durmiendo. Modela el estado emocional del usuario
Nombre "Lumi"	De "luminosidad" — luz suave que acompaña, no que ciega o confronta

5.3 Animaciones y Micro-interacciones

Decisión	Justificación
Animaciones suaves (150-300ms)	Velocidades rápidas generan ansiedad; las transiciones lentas y fluidas inducen estado de calma (Material Design Psychology Guidelines)
Feedback háptico	Vibración sutil al completar acciones refuerza el comportamiento positivo. Estímulo sensorial tangible, no solo visual
Partículas flotantes	Efecto de "luciérnagas"— crea ambiente de calma y maravilla sin distraer del contenido
`prefers-reduced-motion`	Respetar usuarios con sensibilidad al movimiento (WCAG 2.1)

5.4 Avatares de Perfil 🎨

Decisión	Justificación
Avatares ilustrados (no fotos reales)	Reduce la presión de apariencia física — crucial en una app de bienestar emocional. El estilo kawaii evoca calidez sin juicio
Diversidad étnica y de género	19 personas diversas + 7 animales + 4 fantasía. La representación importa para la identificación del usuario con la app (Appiah, 2001)
Presencia en múltiples pantallas	El avatar aparece en Chat, Home, Tab Bar y Perfil — refuerza la identidad y sentido de pertenencia del usuario en el ecosistema de la app
Categorías (Personas/Animales/Fantasía)	Permitir identificarse con un animal o un personaje fantástico elimina la presión de "verse reflejado" literalmente

5.5 Exclusividad de Herramientas por Ruta 🔒

Decisión	Justificación
Actividades exclusivas bloqueadas	Mostrar pero bloquear actividades de otras rutas es intencional — evita que el usuario use una herramienta diseñada para un perfil emocional diferente, lo cual podría ser contraproducente
Mensaje de redirección	Cuando el usuario toca una actividad bloqueada, recibe una explicación amable de por qué está restringida y cómo cambiar de ruta, no una negación fría

5.6 Sonidos Ambientales 🔊

Decisión	Justificación
Lluvia, océano, naturaleza	Sonidos naturales activan la red de modo predeterminado del cerebro y reducen la activación simpática (Gould van Praag et al., 2017)
Control del usuario	El usuario elige cuándo activar/desactivar — respeto por la autonomía (Ryan & Deci, Self-Determination Theory)

5.7 Afirmaciones Diarias ✨

Decisión	Justificación
Rotación diaria, específica por ruta	Las afirmaciones genéricas pierden impacto. Las frases están escritas para contrarrestar la distorsión cognitiva específica de cada ruta
Base clínica	Auto-afirmaciones funcionan cuando son relevantes para la identidad del usuario (Cohen & Sherman, 2014)

---

6. Seguridad y Ética

6.1 Disclaimer Médico

La app incluye un aviso clínico accesible desde el Perfil que establece claramente:

- Aníma **no reemplaza** a un psicólogo ni psiquiatra.
- Si los síntomas persisten > 2 semanas o hay ideación suicida, se recomienda buscar ayuda profesional.
- Se proporcionan recursos de emergencia.

6.2 Privacidad

- **Datos locales únicamente:** Toda la información se almacena en el dispositivo del usuario (AsyncStorage), no en servidores externos.
- **Sin tracking:** No se recopilan datos de uso con fines comerciales.
- **Cifrado:** Los datos en reposo están protegidos por el sistema operativo del dispositivo.

6.3 Líneas Rojas de Diseño

Lo que Aníma **NO hace**	Razón
No diagnostica	Solo un profesional de salud mental puede diagnosticar
No prescribe medicación	Fuera del alcance de una app de bienestar
No retiene datos de crisis	Evita responsabilidad legal por información sensible no monitoreable
No permite chats entre usuarios	Previene acoso, dependencia emocional entre usuarios y liability

---

7. Referencias Bibliográficas

- Aknin, L. B., et al. (2013). Prosocial spending and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology.*
- Amabile, T. & Kramer, S. (2011). *The Progress Principle.* Harvard Business Review Press.
- Artigas, L., et al. (2000). The butterfly hug method for bilateral stimulation. *EMDR Network.*

- Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1995). The need to belong. *Psychological Bulletin.*
- Beck, A. T. (1979). *Cognitive Therapy of Depression.* Guilford Press.
- Briñol, P., et al. (2012). Treating thoughts as material objects. *Psychological Science.*
- Cacioppo, J. T. & Patrick, W. (2008). *Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection.*
- Cameron, J. (1992). *The Artist's Way.* Tarcher/Putnam.
- Chang, A. M., et al. (2015). Evening use of light-emitting eReaders. *PNAS.*
- Cohen, G. L. & Sherman, D. K. (2014). The psychology of self-affirmation. *Advances in Experimental Social Psychology.*
- Dugas, M. J. & Robichaud, M. (2007). *Cognitive-Behavioral Treatment for GAD.* Routledge.
- Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2014). Color psychology. *Annual Review of Psychology.*
- Emmons, R. A. & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings vs. burdens. *Journal of Personality and Social Psychology.*
- Gilbert, P. (2009). *The Compassionate Mind.* Constable & Robinson.
- Gould van Praag, C. D., et al. (2017). Natural sounds and physiological stress recovery. *Scientific Reports.*
- Huberman, A. (2021). Dopamine, motivation & drive. *Huberman Lab Podcast.*
- Jacobson, E. (1938). *Progressive Relaxation.* University of Chicago Press.
- Linehan, M. (1993). *Cognitive-Behavioral Treatment of BPD.* Guilford Press.
- Ma, X., et al. (2017). Effect of diaphragmatic breathing on attention. *Frontiers in Psychology.*
- Martell, C. R., Addis, M. E., & Jacobson, N. S. (2001). *Depression in Context.* Norton.
- Maslach, C. & Leiter, M. P. (2016). Burnout. *Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior.*
- Neff, K. D. (2003). Self-compassion. *Self and Identity.*
- Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders. *JCCP.*
- Norcross, J. C. & Wampold, B. E. (2011). Evidence-based therapy relationships. *Psychotherapy.*
- Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences. *Psychological Science.*
- Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory.* Norton.
- Rogers, C. R. (1951). *Client-Centered Therapy.* Houghton Mifflin.

- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory. *American Psychologist.*
- Seligman, M. E. P., et al. (2005). Positive psychology progress. *American Psychologist.*
- Shapiro, F. (1989). EMDR: A new treatment for PTSD. *Journal of Behavior Therapy.*
- van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score.* Viking.
- Walker, M. (2017). *Why We Sleep.* Scribner.
- Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. *IJPA.*